



GUÍA DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA

Versión N° 0 - 2025

Fecha de vigencia: 29/12/2025

Hospital Dr. Humberto J. Notti

GUIA HOSPITALARIA

TIPO DE DOCUMENTO: GUIA HOSPITALARIA

NOMBRE: GUIA DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA

VERSION: 0- AÑO 2025

SERVICIOS INTERVINIENTES

Servicio De Epidemiología y Control de Infecciones- Autores principales

GRUPO REVISOR 2025:

- Servicio Infectología
- Departamento de Cirugía
- Departamento de Enfermería
- Sección de Enfermería en Control de Infecciones
- Departamento de Anestesiología
- Departamento de Farmacia
- Servicio de Internación Pediátrica 4
- Departamento de Áreas Críticas
- Departamento de Internación

Contenido

1)INTRODUCCIÓN	4
2) RECOMENDACIONES	4
2.1 Período pre-quirúrgico	4
2.2 Baño prequirúrgico (ver Anexo II)	5
3) PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PREQUIRÚRGICA (PAP)	5
3.1 Generalidades	5
3.2 Tabla de dosificación de antimicrobianos en pediatría (ver ANEXO III)	6
4) GUÍA DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA	6
4.1 Cirugía traumatológica	6
4.1.1 Sin indicación de PAP	8
4.1.2 Comentarios generales:	8
4.1.2.1 Uso de antibióticos en cementos:	8
4.1.2.2 Colonización/Infección por <i>Staphylococcus aureus</i> (ver ANEXO I)	9
4.1.2.3 Infección articular previa	9
4.2 Cirugía de cabeza y cuello	9
4.2.1 Sin indicación de PAP	10
4.2.2 Consideraciones en las cirugías limpias sin indicación de profilaxis antibiótica	11
4.3. Cirugía Maxilofacial	11
4.4 Cirugía Plástica	12
4.4.1 Sin indicación de PAP	13
4.5 Cirugía oftalmológica	13
4.6 Cirugía torácica	14
4.6.1 Sin indicación de PAP	15
4.7 Cirugía cardiovascular	15
4.7.1 Sin indicación de PAP	17
4.7.2 Consideraciones especiales	17
4.8 Neurocirugía	18
4.8.1 Colonización/Infección por <i>Staphylococcus aureus</i> (ver ANEXO I)	19
4.9 Cirugías urológicas	19
4.9.1 Sin indicación de PAP:	20
4.10 Cirugía abdominal	21
4.10.1 Sin indicación de PAP	26
ANEXO 1	26
ANEXO 2	28

ANEXO 3.....	31
5) BIBLIOGRAFÍA.....	33

1)INTRODUCCIÓN

Las Infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) son la tercera causa de infecciones nosocomiales. Basados en los pocos estudios disponibles, se calcula que la cifra es de 2 a 20 veces más elevada en los países en vías de desarrollo.

La mayoría de las ISQ se originan durante el procedimiento quirúrgico. Los reservorios de microorganismos causantes son, principalmente, la flora endógena del paciente.

De acuerdo a la epidemiología nacional e internacional los gérmenes más frecuentemente aislados son: *Staphylococcus aureus* (SA), *Staphylococcus epidermidis* (SCN) y Bacilos Gram negativos (BGN), principalmente *Escherichia coli*. Menos frecuentes anaerobios (AN), *Streptococcus spp* (Str) y *Bacillus cereus* (BC), dependiendo del sitio involucrado.

2) RECOMENDACIONES

2.1 Período pre-quirúrgico

- Evaluación clínica del paciente
- Evaluación score de ASA
- Vacunación antitetánica completa
- Estadía hospitalaria previa: lo más corta posible
- **HISOPADO DE PLIEGUES Y NARINAS:**

Todo paciente sometido a las siguientes cirugías (independientemente de los factores de riesgo anunciados debajo) deberá tener hisopados para la búsqueda de *Staphylococcus aureus* (SA) **antes del procedimiento** (ver ANEXO I):

- ✓ Cirugías cardiovasculares
- ✓ Neurocirugía
- ✓ Cirugía traumatológica con colocación de implantes

✓ Procedimientos con colocación de implantes

Todo paciente sometido a otro procedimiento quirúrgico (no listado arriba) deberá tener hisopados para la búsqueda de SA antes del procedimiento, sólo si presenta al menos uno de los siguientes factores de riesgo [13]:

- Pacientes en hemodiálisis crónica, pacientes con adicción a drogas EV, pacientes diabéticos insulín dependientes y pacientes con enfermedades agudas y crónicas de la piel.
- Pacientes con antecedentes previos de colonización por SA.
- Historia de forunculosis personal o familiar.
- Hospitalización prolongada, uso de catéteres intravasculares.

En caso de que el paciente no presente vacunación antitetánica completa para la edad, así como también hisopados nasales y de pliegues según lo establecido, la cirugía será reprogramada hasta que dichos ítems se cumplan en su totalidad.

2.2 Baño prequirúrgico (ver Anexo II)

3) PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PREQUIRÚRGICA (PAP)

3.1 Generalidades

Objetivo: prevenir la aparición de infección del sitio quirúrgico (ISQ) a través de lograr alcanzar niveles de concentración óptima de los antibióticos en sangre y tejidos, para evitar la proliferación y diseminación bacteriana [6].

Su uso inapropiado selecciona microorganismos resistentes exponiendo al paciente a reacciones adversas y aumenta los costos.

La profilaxis antimicrobiana quirúrgica está indicada en cirugías con mayor riesgo de infección tales como las cirugía limpia-contaminada, y para aquellas cirugías con menor riesgo clasificadas como limpias, pero en las cuales las infecciones pueden desencadenar una complicación grave (por ejemplo: cirugías con prótesis o dispositivos).

La administración del antimicrobiano **debe realizarse en quirófano, en la inducción anestésica**, para asegurar niveles adecuados en sangre y tejidos durante

el periodo de mayor riesgo de contaminación, y de esta manera, disminuir la posibilidad de desarrollar una ISQ [12].

En el caso que se indique **Vancomicina o Ciprofloxacina, se recomienda iniciar la infusión por goteo, dos horas antes de la incisión quirúrgica. [12]**

En las cirugías donde se utiliza manguito para la presión de oclusión del miembro locomotor se recomienda completar la infusión antes de insuflar el mismo.

Cuando la duración del procedimiento excede las 2 vidas media del fármaco se indica refuerzo del antibiótico (en el caso de la Cefazolina: cuatro horas).

Otras situaciones en las cuales debe administrarse un refuerzo son: **cuando el recambio de la volemia es mayor al 50% y en pacientes quemados.**

Nunca debe prolongarse la PAP más allá de las 24 horas postoperatorias (excepto casos puntuales)

La presencia de drenajes y catéteres no justifica la prolongación de la PAP.

3.2 Tabla de dosificación de antimicrobianos en pediatría (ver ANEXO III)

4) GUÍA DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA

4.1 Cirugía traumatológica

Los procedimientos quirúrgicos en traumatología y ortopedia son en su mayoría cirugías limpias. Las cirugías osteoarticulares con colocación de implantes/prótesis tienen una baja incidencia de infección sitio quirúrgico (ISQ) pero su infección está asociada a una gran morbilidad; siendo la profilaxis antibiótica una de las estrategias recomendadas para prevenir la formación de biopelículas bacterianas (producidas frecuentemente por *S. aureus* y *S. epidermidis*).

Procedimiento	Esquema ATB	Alternativa	Duración
Fractura expuesta grado III a	Cefazolina+ Gentamicina	Clindamicina+ Gentamicina	Pre inducción anestésica y hasta

			24 horas máximo
Fractura expuesta grado III b y c	Cefazolina + Gentamicina	Clindamicina + Gentamicina	Pre-inducción y luego por 72 horas. y 24 horas después del cierre de las heridas
Fractura expuesta grado I-II	Cefazolina	Vancomicina o Clindamicina	Pre inducción anestésica y hasta 24 horas máximo
Colocación prótesis/ material osteosíntesis o dispositivo de fijación (tornillo, clavo, placa)	Cefazolina (*ver punto 4.1.2.2)	Vancomicina	Pre inducción anestésica y hasta 24 horas máximo
Amputación Traumática o pos isquémica con gangrena	Ampicilina Sulbactam+ Gentamicina	Clindamicina+ Gentamicina	24 horas
Amputación Pos isquémica (sin gangrena)	Cefazolina	Vancomicina	No más de 24 horas
Otros procedimientos (cirugía columna, fijación fractura cerrada)	Cefazolina	Vancomicina	Pre inducción anestésica

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

Resección de tumores óseos o grandes cirugías de partes blandas			
NEONATOLOGÍA			
Fracturas no expuestas Columna Amputación Colocación de material protésico	Cefazolina	Clindamicina	Monodosis

4.1.1 Sin indicación de PAP

- Cirugía electiva a cielo abierto sin colocación de prótesis osteoarticulares ni material de osteosíntesis.
- Cirugía de mano, rodilla y pie sin colocación de prótesis articulares ni material de osteosíntesis.
- Biopsia ósea.
- Retiro de material de osteosíntesis.

4.1.2 Comentarios generales:

4.1.2.1 Uso de antibióticos en cementos:

El uso de cementos con antibióticos no excluye la utilización de antibióticos por vía sistémica. Su uso estaría indicado en las revisiones de prótesis articular en dos tiempos o en la colocación de espaciadores. No deben agregarse antibióticos en quirófano a los cementos que no los contienen. Para la colocación de prótesis

articulares puede asociarse a la profilaxis endovenosa la aplicación de cemento impregnado en antibiótico, en pacientes de alto riesgo como pacientes diabéticos, inmunocomprometidos, obesos, múltiples comorbilidades y antecedentes de infección. [13]

4.1.2.2 Colonización/Infección por *Staphylococcus aureus* (ver ANEXO I)

4.1.2.3 Infección articular previa

Los pacientes con antecedentes de infección en la articulación que van a ser nuevamente intervenidos quirúrgicamente deben recibir profilaxis antibiótica según el o los microorganismos hallados con anterioridad, con interconsulta previa al servicio de Infectología. [13]

4.2 Cirugía de cabeza y cuello

Los procedimientos electivos de cabeza y cuello son predominantemente limpios o limpio-contaminados. Sobre la base de la mejor evidencia disponible, recomendamos el uso de profilaxis antimicrobiana para la mayoría de los procedimientos limpio- contaminados. [13]

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Cirugía con prótesis materiales exógenos y grandes Desplazamientos de piel y tejidos subcutáneos.	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina
Cirugía mayor de cabeza y cuello que atraviesa cavidad oral o cirugía mayor de cabeza y cuello (incluida Cirugía Fisura palatina)	Cefazolina+ Metronidazol	Monodosis	Ampicilina Sulbactam/ o Clindamicina

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

			(alérgicos a betalactámicos)
Cirugía auditiva con implante coclear	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina O Ceftriaxona
Atresia de coanas	Cefazolina + Metronidazol o Ampicilina-Sulbactam	Monodosis	Clindamicina

4.2.1 Sin indicación de PAP

- Amigdalectomía (considerar profilaxis en pacientes con alto riesgo de **endocarditis infecciosa**: estado nutricional deficiente, obesidad, diabetes, infección coexistente en otro foco, colonización por *Staphylococcus aureus* nasal, inmunosupresión, pacientes oncológicos en tratamiento (radioterapia y/o quimioterapia) y estancia preoperatoria prolongada).
- Adenoidectomía
- Colocación de tubos de ventilación transtimpánica
- Cirugía limpia de oído sin implante coclear
- Cirugía limpia que no atraviesa cavidad oral y cuello
- Cirugía de nariz y senos paranasales

4.2.2 Consideraciones en las cirugías limpias sin indicación de profilaxis antibiótica

Se recomienda profilaxis quirúrgica cuando se atraviesa mucosa gingival, periapical o en amigdalectomía y adenoidectomía en pacientes con las siguientes patologías cardíacas: [13]

- ❖ Pacientes con antecedentes de reemplazo valvular protésico o material protésico utilizado para reparación de válvula cardíaca.
- ❖ Pacientes con endocarditis infecciosa previa.
- ❖ Pacientes con patologías cardíacas congénitas:
 - a. Enfermedad cardíaca congénita cianótica no reparada o con defectos subyacentes luego de su reparación o realización de shunts o conductos paliativos.
 - b. Enfermedad cardíaca congénita reparada completamente con material protésico en forma quirúrgica o percutánea hasta luego de 6 meses de su realización.
 - c. Toda aquella condición en la cual persista un defecto residual en el sitio de colocación de material protésico o dispositivo, ya sea mediante procedimiento quirúrgico cardíaco o técnica percutánea.

En pacientes con antecedentes oncológicos, exposición prolongada a antibioticoterapia, colonización confirmada por microorganismo multiresistente, realizar interconsulta previa con servicio de Infectología para evaluar ampliar cobertura profiláctica.

4.3. Cirugía Maxilofacial

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Reducción cerrada o abierta de fractura mandibular	Cefazolina.	Monodosis	Clindamicina o Ampicilina - Sulbactam
NEONATOLOGÍA			

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

Fractura mandibular/cráneo	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina
----------------------------	------------	-----------	--------------

4.4 Cirugía Plástica

El riesgo de infección varía de acuerdo al tipo de procedimiento. Si bien la tasa de infección de sitio quirúrgico es baja alrededor del 1%, para las cirugías reconstructivas amplias como para aquellas que usan implantes o las efectuadas en pacientes con obesidad y grandes reducciones de piel o del panículo adiposo, el riesgo de infección es mayor [13].

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Cirugía plástica con inclusión de prótesis, materiales exógenos o grandes despegamientos de piel o Tejido Subcutáneo SIN o CON drenajes	Cefazolina	Monodosis (pre inducción sin drenajes) con drenajes 24 horas	Ampicilina-Sulbactam
Cirugía limpia o limpia-contaminada o contaminada con incisión de mucosa orofaríngea (glándulas salivales, fisura labiopalatina, injerto óseo intraoral)	Ampicilina-sulbactam	Pre inducción hasta 24 horas	
NEONATOLOGÍA			
Partes blandas y pared	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina o Vancomicina
Escarectomía			
Biopsia ganglio			
Exéresis tumoral			

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

4.4.1 Sin indicación de PAP

Cirugía plástica sin inclusión de prótesis, materiales exógenos o grandes despegamientos de piel y tejido subcutáneo.

4.5 Cirugía oftalmológica

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Traumatismo penetrante	Ceftazidima + Vancomicina inyección intravítreal en dosis única		Gentamicina + vancomicina Inyección intravítreal en dosis única
Cirugías oftalmológicas programadas (cataratas, glaucoma, implante corneal, lente intraocular, queratoplastia)	Limpieza de la piel de los párpados con povidona yodada al 10%, instilación de povidona yodada al 5% sobre la superficie ocular y fondos de saco conjuntival durante 3 minutos antes de iniciarse la cirugía. En todos los procesos quirúrgicos al finalizar la cirugía se añade una gota de povidona al 5% en la superficie ocular y una gota de Tobramicina tópica.		
Enucleación con o sin colocación de prótesis	Cefazolina	Monodosis Pre inducción	Vancomicina
Cirugía lagrimal	Cefazolina	Única dosis	Vancomicina
NEONATOLOGÍA			
Glaucoma Enucleación Cataratas	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina o Vancomicina

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

Ablación láser	No requiere profilaxis		
----------------	------------------------	--	--

4.6 Cirugía torácica

El objetivo de la profilaxis pre quirúrgica es la disminución de la ISQ, en este tipo de cirugías también juegan un rol fundamental factores tales como la posibilidad de desarrollar neumonía o empiema. Algunos factores de riesgo independientes para el desarrollo de neumonía después de procedimientos torácicos son: resección pulmonar extensa, colonización bronquial intraoperatoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, IMC > Pc 95, radio y/o quimioterapia, enfermedad oncológica terminal (III-IV) [13].

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Resección pulmonar-lobectomía- neumonectomía-toracotomía-videotoracoscopia Cirugía de mediastino Traqueotomía	Cefazolina	Monodosis	Ampicilina-Sulbactam o Clindamicina o Vancomicina
Cierre de fistula traqueo-esofágica-neumotórax- drenaje de supuración pleural o pleurosis abierta-quiste hidatídico o broncogénico			
Resección de pared torácica-corrección de malformación de la pared torácica- cirugía oncológica de pared torácica y mediastino, timectomia, diafragma.			
NEONATOLOGÍA			

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

Lobectomía	Cefazolina	25 mg/kg /dosis	
Neumonectomía			
Hernia Diafragmática Congénita		Luego 20 mg/kg/dosis solo 2 dosis postquirúrgicas	
Tumor mediastino			
Biopsia pulmonar			
cuerdas vocales tumor nasal o cavidad oral	Ampicilina-sulbactam	50 a 100 mg/kg Y luego 50 c/8 Sólo 2 dosis Post Q	Clindamicina o Vancomicina

4.6.1 Sin indicación de PAP

- Colocación de tubo pleural en situación no traumática.
- Traumatismo de tórax
- Resección de tumor solitario de la pleura

4.7 Cirugía cardiovascular

La cirugía cardiovascular conlleva una elevada morbilidad y se ha demostrado que la profilaxis antibiótica reduce cinco veces las infecciones quirúrgicas.

Las infecciones del sitio quirúrgico están favorecidas por la hipotermia, la degradación de los factores de coagulación que predisponen al sangrado, la duración prolongada del procedimiento (3-4 horas) y la presencia de drenajes y catéteres post quirúrgico [13].

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Cirugía cardíaca abierta	Cefazolina	Preinducción y hasta 48 horas posteriores	Vancomicina o Clindamicina
Cirugía cardíaca abierta CON bomba de circulación extracorpórea	Cefazolina	Pre inducción y hasta 48 horas con dosis extra al ingreso y salida de bomba	Vancomicina o Clindamicina
Cirugía cardíaca abierta CON tórax abierto postquirúrgico	Cefazolina en pre inducción	Nota: luego continuar con Piperacilina-tazobactam + vancomicina hasta 24 horas post cierre de tórax.	Vancomicina o Clindamicina
Inserción de dispositivo cardíaco (marcapaso, asistencia ventricular)	Cefazolina	Pre inducción y hasta 48 horas	Vancomicina o Clindamicina
Trasplante cardíaco o cardiopulmonar			
Cirugía Vascular (abdominal, miembros inferiores, reconstrucción arterial, diálisis)		Pre inducción y hasta 24 horas	
NEONATOLOGÍA			
Cerradas	Cefazolina	Monodosis	
Cerradas con infección previa SA	Vancomicina	Monodosis	
Abiertas (CEC)			

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025	
ECMO neonatal		Al precanulación	Iniciar

4.7.1 Sin indicación de PAP

- Colocación de catéter de Swang- Ganz, catéter venoso central
- Colocación de marcapasos transitorio
- Estudios hemodinámicos /cateterismo
- Arteriografías
- Cirugía de vasos del cuello
- Cirugía de vasos de miembros superiores
- Cirugía de várices y otras cirugías venosas
- Intervención coronaria percutánea DI
- Angioplastia/Inserción de stent
- Valvuloplastia balón aórtico y mitral
- Procedimientos de ablación

4.7.2 Consideraciones especiales

- Los pacientes pasibles de cirugía cardiovascular deberían ser sometidos a screening para búsqueda de *S. aureus* (ver ANEXO I).**
- En pacientes con colonización previa documentada por SAMR, se recomienda el agregado de **vancomicina** a la profilaxis con cefazolina.
- No hay recomendación de prolongación de la profilaxis post operatoria en pacientes que requieren catéteres y/o drenajes hasta su remoción, debido al riesgo de desarrollar microorganismos multirresistentes, superinfecciones y/o toxicidad por drogas. Si la cirugía involucra aorta abdominal o incisión femoral, se recomienda sumar aminoglucósidos, a la indicación de la vancomicina.

Considerar profilaxis antibiótica en los procedimientos de colocación de stent o injertos si hay presencia de factores de riesgo de infección, realizando interconsulta con el servicio de Infectología, en el caso de [13]:

- Procedimientos prolongados mayor de 2 horas
- Re intervención dentro de los 7 días
- Permanencia prolongada de catéter arterial (más de 24 horas)

4.8 Neurocirugía

Todos los procedimientos necesitan PAP. Los principales gérmenes responsables de las infecciones son los cocos Gram positivos (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* y otros coagulasa negativos) y con menor frecuencia: *Cutibacterium acnés* y bacilos Gram negativos (5-8%).

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Colocación de sistema de derivación de LCR o prótesis (microplaquetas, catéter de PIC) Implante de bomba intratecal	Cefazolina	Hasta 24 horas	Vancomicina
Transectenoidal o con pasaje por otras mucosas	Ampicilina-Sulbactam	Hasta 24 horas	Vancomicina + Clindamicina
Craneotomía/laminectomía u otras que no atraviesan mucosa sinusal u oral (incluye neuroendoscopia) Craneoplastia limpia sin prótesis (exéresis de tumores, biopsias, evacuación de hematomas) Fractura de cráneo	Cefazolina	Hasta 24 horas	Vancomicina
Traumatismo penetrante de SNC	Cefotaxima + Metronidazol	Hasta 24 horas	Clindamicina
NEONATOLOGÍA			
Cirugías limpias			

Craneotomía, MMC cerrado y fractura abierta de cráneo	Cefazolina	Monodosis en fractura abierta de cráneo prolongar 3 a 5 días	
MMC abierto	Cefotaxima	Monodosis	
DVP (shunt o prótesis)	Cefazolina	Hasta 24 horas	
Cirugías limpia/ contaminada			
Transesfenoidal y otras vía mucosa sinusal u oral	Ampicilina-sulbactam	24 horas	

4.8.1 Colonización/Infección por *Staphylococcus aureus* (ver ANEXO I)

4.9 Cirugías urológicas

Procedimiento	Esquema ATB	Duración	Alternativa
Cirugía urológica limpia o limpias contaminadas en donde se aborde el tracto urinario en forma controlada que no involucra vísceras del tracto digestivo (endoprostática, endovesical, abdominal o nefrectomía, colocación de prótesis, litotricia) con urocultivo negativo*	Cefazolina	Monodosis	Gentamicina
Cirugía urológica con manipulación de vísceras del tubo digestivo con urocultivo negativo*	Metronidazol + Gentamicina	Monodosis	

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

Urodinamias en pacientes con factores de riesgo: inmunocomprometidos, reflujo vesicoureteral, vejiga neurógena	Trimetoprima Sulfametoxazol	Monodosis	Clindamicina + Gentamicina
NEONATOLOGÍA			
Obstrucción de la vía y/o involucra víscera intestinal	Ampicilina-sulbactam	Dosis inducción anestésica y 2 dosis postquirúrgicas	
Reflujo	Cefazolina	Dosis inducción anestésica y 2 dosis postquirúrgicas	
Ureterostomía			
Biopsia renal			

*Si el **urocultivo es positivo**, tratar antes infección urinaria, y realizar la cirugía luego de un urocultivo postratamiento de control negativo. Si esto no se puede realizar hacer tratamiento de infección con antibiótico adecuado a urocultivo por 72 horas y administrar una dosis del mismo preinducción de la cirugía, luego completar tratamiento antibiótico.

Evaluar con servicio de Infectología de acuerdo a los cultivos obtenidos y susceptibilidad de cultivos previos

En caso de litiasis, poliquistosis u otras anomalías obstructivas es recomendable revisar los antecedentes microbiológicos previos.

4.9.1 Sin indicación de PAP:

- Resección endovesical de tumores
- Uroflujometrías, urodinamias en pacientes no complicados

- Procedimientos endoscópicos sin resección ni biopsia
- Ureterotomías
- Cistoscopías
- Hipospadias simples
- Circuncisión en pacientes no complicados
- Orquidopexia

4.10 Cirugía abdominal

Procedimiento	Esquema electivo	Duración	Alternativa
Hernioplastia con colocación de malla abierta o laparoscópica (umbilical, inguinal, crural)	Cefazolina	Monodosis	Vancomicina o Clindamicina *
Hígado, Vías biliares. Abierto o laparoscópico en pacientes de alto riesgo, (colecistectomía, derivación biliar digestiva en atresia de vías biliares y quiste de colédoco):	Ampicilina sulbactam	Monodosis	Gentamicina+ Clindamicina
Hígado: hepatectomías, biopsia, exéresis de quiste hidatídico y otros tumores benignos. Páncreas: tumores, quistes, hiperinsulinismo	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina o Vancomicina

Esófago (atresia, acalasia, esofagostomías, reemplazo de esófago) Gastroduodenal y estómago (gastrostomía, derivaciones bilio-digestivas, cirugía anti reflujo, hernia hiatal, pilorostomía, cirugía bariátrica)	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina o Vancomicina
Intestino Delgado	SIN OBSTRUCCION: cefazolina CON OBSTRUCCIÓN: Ampicilina sulbactam	Monodosis	Clindamicina + Gentamicina / Metronidazol + Gentamicina
Apendicetomía Abdomen agudo quirúrgico Colorectal (confección y cierre de colostomía, colectomía, cirugía de megacolon y Hirschsprung, y malformaciones ano rectales)	Metronidazol +Gentamicina	Monodosis	Ampicilina -Sulbactam
Traumatismo penetrante de abdomen	Preparación mecánica del colon Metronidazol+ Gentamicina	Monodosis	
Laparoscopias de alto riesgo *	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina + Gentamicina

Cirugía esplénica	Cefazolina.	Monodosis	Clindamicina o Vancomicina
NEONATOLOGÍA			
Cirugías limpias			
Hernia inguinal	Cefazolina	Monodosis	Clindamicina
Biopsia hepática			
Esplenectomía			
Cirugías limpias/ contaminadas			
Atresia de esófago (sin sufrimiento visceral y no perforada, sin obstrucción)	Cefazolina	Sólo 2 dosis post quirúrgicas	Clindamicina
Gastrotomía (sin sufrimiento visceral y no perforada, sin obstrucción)		Sólo 2 dosis post quirúrgicas	Clindamicina
Atresia intestinal	Ampicilina- sulbactam	Pre inducción Sólo 2 dosis post quirúrgicas	Metronidazol + Gentamicina
Biliar o pancreática			
Ovariectomía			
Biopsia rectal			

Anoplastía o descenso de colón			
Cirugías contaminadas			
Gástrica por hemorragia, úlcera o rotura	Ampicilina sulbactam	Pre inducción Sólo 2 dosis post quirúrgicas	Metronidazol + Gentamicina
Cirugías sucias			
Cierre fistula vesico-rectal	Metronidazol +Gentamicina	Pre inducción Sólo 2 dosis post quirúrgicas	
Cirugía de colon rectal Cierre de ostomías		Preinducción Sólo 2 dosis post quirúrgicas	Metronidazol + gentamicina
Onfacele- gastroquisis perforado		Preinducción y 10 días de tratamiento	Metronidazol + gentamicina

Enterocolitis necrotizante (NEC)		Preinducción y 10 días de tratamiento	Metronidazol + gentamicina
Drenaje absceso		Tratamiento según germen por antibiograma y evolución	
Cirugía intestinal con isquemia		Tratamiento según germen por antibiograma y evolución	
Recidiva de Cirugía pared			Germen aislado previamente según antibiograma
PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS			
Gastrostomía y yeyunostomias endoscópica percutánea. Miotomía endoscópica esofágica (tratamiento de acalasia)	Cefazolina .	Monodosis	Ampicilina Sulbactam o Vancomicina + Gentamicina
Escleroterapia esofágica, ligadura de várices	Ceftriaxona	monodosis	
Dilatación esofágica		monodosis	

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

PCRE - Obstrucción biliar, cuando no se logra un completo drenaje biliar	Ceftriaxona en pacientes con factores de riesgo para colangitis secundaria.	monodosis	Factores de riesgo colangitis: drenaje incompleto de la VB, pos trasplante hepático, colangitis esclerosante 1 o tumores biliares e inmunocomprometidos. Alternativa: Piperacilina Tazobactam o Gentamicina
Miotomía endoscópica gástrica	Metronidazol + Gentamicina	monodosis	

* Los factores asociados a alto riesgo de infección incluye aquellos procedimientos de emergencia, diabéticos, duración prolongada del procedimiento, colecistitis edematosa, gangrenosa o perforación, ictericia, colédoco-litiasis, colangitis, colecistitis aguda en los últimos 6 meses, pancreatitis litiásica, antibioticoterapia en el último mes, ASA ≥ 3 , cólico biliar en los 30 días previos, inmunosupresión y embarazo.

4.10.1 Sin indicación de PAP

- Hernioplastia sin colocación de malla
- Colecistectomía laparoscópica de bajo riesgo
- Funduplicatura de Nissen por vía laparoscópica
- Onfaloceles reducidos inmediatamente luego del nacimiento
- Colocación de catéter de acceso venoso central

ANEXO 1

PESQUISA DE COLONIZACIÓN POR *Staphylococcus aureus*

1. Alcance

Todo paciente sometido a las siguientes cirugías (independientemente de los factores de riesgo anunciados debajo) deberá tener hisopados para la búsqueda de *Staphylococcus aureus* (SA) (SAMS/SAMR) **antes del procedimiento**:

- ✓ Cirugías cardiovasculares
- ✓ Neurocirugía
- ✓ Cirugía traumatológica con colocación de implantes
- ✓ Procedimientos con colocación de implantes

Todo paciente sometido a otro procedimiento quirúrgico (no listado arriba) deberá tener hisopados para la búsqueda de SA antes del procedimiento, sólo si presenta al menos uno de los siguientes factores de riesgo [13]:

- Pacientes en hemodiálisis crónica, pacientes con adicción a drogas EV, pacientes diabéticos insulino dependientes y pacientes con enfermedades agudas y crónicas de la piel.
- Pacientes con antecedentes previos de colonización por SA.
- Historia de forunculosis personal o familiar.
- Hospitalización prolongada, uso de catéteres intravasculares.

2. Procedimiento para la pesquisa

El médico cirujano tratante deberá solicitar la realización de **hisopado nasal y de pliegues (axilar e inguinal)** para la búsqueda de SAMS y SAMR **entre 7 y 10 días previos a la cirugía**.

3. Descolonización

Si alguno de los hisopados resulta positivo para SAMS o SAMR, se indicará el siguiente esquema de descolonización:

1. **Mupirocina al 2% intranasal** (ungüento): aplicar dos veces por día durante 5 días.
2. **Baños diarios con clorhexidina jabonosa al 4%** durante los 5 días previos a la cirugía, incluyendo un baño el mismo día del procedimiento. (ver ANEXO II)

4. Profilaxis antibiótica

- **Pacientes colonizados por SAMR:** cefazolina + vancomicina (administrar de forma lenta).
 - En cirugías transesfenoidales o con abordaje a través de otras mucosas, utilizar **clindamicina + vancomicina**.
- **Pacientes colonizados por SAMS:** mantener la profilaxis estándar con cefazolina.

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) constituyen una de las principales complicaciones posoperatorias. El baño prequirúrgico y otras medidas preventivas basadas en evidencia disminuyen la incidencia de infecciones. Se proponen las siguientes recomendaciones según el tipo de cirugía.

1. Cirugías Generales:

- Deben hacerse tres baños antes de la cirugía: el primero en casa con jabón neutro, el segundo la noche anterior y el tercero 1-2 horas antes del procedimiento, ambos con jabón de clorhexidina al 4%.
- Después de aplicar el jabón de clorhexidina, espere entre 2 y 3 minutos antes de enjuagar.
- El procedimiento del baño prequirúrgico debe realizarse mediante fricción, teniendo especial énfasis en la zona donde se realizará la intervención quirúrgica. Evitar el contacto del jabón de clorhexidina con boca, nariz, ojos y genitales.
- Secar con toalla limpia y realizar cambio de ropa. Después de último baño colocar bata y gorro.

2. Cirugías cardiovasculares, traumatológicas con prótesis y neurocirugías

- Se deben realizar seis baños pre quirúrgicos con jabón de clorhexidina 4%: tres en casa (uno por día en los tres días previos) y tres durante la internación (tarde, noche y mañana 1-2 horas antes del procedimiento).
- Después de aplicar el jabón de clorhexidina, espere entre 2 y 3 minutos antes de enjuagar.
- El procedimiento del baño prequirúrgico debe realizarse mediante fricción, teniendo especial énfasis en la zona donde se realizará la intervención quirúrgica. Evitar el contacto del jabón de clorhexidina con boca, nariz, ojos y genitales.
- Secar con toalla limpia y realizar cambio de ropa. Después de último baño colocar bata y gorro.

3. Cirugías en pacientes colonizados por SAMR/ SAMS

- Deben realizarse ocho baños pre quirúrgicos con jabón de clorhexidina 4%: cinco en casa (uno por día los cinco días previos) y tres durante la internación (tarde, noche y mañana 1-2 horas antes del procedimiento).
- Después de aplicar el jabón de clorhexidina dejar actuar de entre 2 y 3 minutos antes de enjuagar.
- El baño prequirúrgico debe realizarse mediante fricción, teniendo especial énfasis en la zona donde se realizará la intervención quirúrgica. Evitar el contacto del jabón con clorhexidina con boca, nariz, ojos y genitales.
- Secar con toalla limpia y realizar cambio de ropa. Después de último baño colocar bata y gorro.

IMPORTANTE

- Informar a padre y/o acompañante que el jabón de clorhexidina no debe tocar mucosas ni zonas genitales.
- En cirugías donde se deba realizar baño con jabón de clorhexidina en domicilio, realizar pedido médico para retirar kit de baño pre quirúrgica en farmacia.
- Entregar a padre y/o acompañante folleto instructivo para realizar correctamente los baños pre quirúrgicos.
- Todos los baños pre quirúrgicos realizados en sala de internación deben ser supervisados por personal de enfermería.

ANEXO 3

Tabla de dosificación de antimicrobianos en pediatría

ATB	Vida media (hs)	Dosis pediátrica (mg/kg/dosis)	Dosis adultos (g)	Refuerzo de dosis (cada hs)	Dosis Máxima día
Cefalotina	1	50	2g	2	12 gr
Cefazolina	2	30-50	1g	4	12 gr
Cefuroxima	2	50	1,5g	4	9 gr
Ceftazidima	1,8	50	1 g	4	12 gr
Cefotaxima	1	50	1 g	3	12 gr
Ceftriaxona	8	50	1 g	NO	4 gr
Ampicilina	1	50	2g	2	3 gr
Ampicilina sulbactam	1	50	1,5	2	8 gr

Gentamicina	2	2,5	1,5 mg/k	NO	400 mg
Clindamicina	2	10	600 mg	4	4 gr
Metronidazol	8	25	500 mg	NO	4 gr
Vancomicina	6	15	1g	NO	2 gr
TMS	8-11	10 TMP	160 mg TMP	NO	320 mg
Piperacilina-Tazobactam	1	80-100	3.4gramos	2	16gr

5) BIBLIOGRAFÍA

1. APR Wilson, C. Gibbons, BC Reeves. Surgical wound infection as a performance indicator: agreement of common definitions of wound infection in 4773 patients. BMJ 2004 September 25; 329 (7468); 720.
2. Guideline for Prevention of surgical site infection. Infection Control and Hospital Epidemiology (CDC). 1999. Vol 20 N°4: 247
3. Infección del sitio quirúrgico. Guías para la prevención 2008. Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI)
4. Infección del sitio quirúrgico. Infectología y enfermedades infecciosas. Cecchini y col. Edición 2008.
5. Preventing surgical site infection: A surgeon's perspective. Emerging infectious disease. Vol. 7, number 2, marzo-abril 2001. Ronald Lee Nichols.
6. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, Pickering, M.D. Surgical site infections, pp 591-595.
7. Guía para profilaxis antibiótica en cirugía. Hospital Universitario Austral. Año 2015.
8. Uso de profilaxis antibiótica prequirúrgica. Hospital Garrahan. Año 2014.
9. Guía de profilaxis antibiótica quirúrgica. Sociedad Argentina de Infectología. Actualización 2017.
10. Surgical antibiotic prophylaxis Guidelines. V1. BC Children's Hospital octubre 2017
11. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery Dale W. Bratzler, E. Patchen Dellinger, Keith M. Olsen, Trish M. Perl, Paul G. Auwaerter, Maureen K. Bolon, Douglas N. Fish, Lena M. Napolitano, Robert G. Sawyer, Douglas Slain, James P. Steinberg, and Robert A. Weinstein Am J Health-Syst Pharm—Vol 70 Feb 1, 2013.
12. TIPS temas de Infectología Pediátrica. Programa de actualización. Educación a distancia. Sociedad Argentina de Pediatría. Secretaría de Educación continua. Directora: María Luisa Ageitos: Buenos Aires 2016.

	Guía Hospitalaria: Profilaxis Antibiótica en Cirugía.	Versión: 0 Vigencia: Diciembre 2025 Resol: 1214/2025
---	--	---

13. Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, Asociación Argentina de Cirugía. Guía intersociedades de profilaxis quirúrgica antibiótica en pacientes adultos. 2ª ed. rev. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Sociedad Argentina de Infectología; 2024. Libro digital. ISBN: 978-987-48556-6-4.